

Przerwij cykl

Po epizodzie — **NIE** kompensuj. Każde przerwanie osłabia cykl. Wytrzymanie dyskomfortu 45–90 min uczy mózg, że można tolerować lęk bez wymiotów. Rosen & Leitenberg 1982 — ERP dla bulimii.

CZAS: 30 min · praca między sesjami · Sesje 5–8 CBT-E · po regularnym jedzeniu

ŹRÓDŁO: Fairburn (2008); Rosen & Leitenberg (1982, ERP dla BN)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **logikę przerwania cyklu** (sekcja 1) i **sześć kroków** po epizodzie (sekcja 2). Sekcja 3 — Twój plan awaryjny.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Gdy mimo regularnego jedzenia epizod się zdarzy — **nie** pozwól, by cykl zakończył się kompensacją. Rosen & Leitenberg (1982) zaadaptowali model *ekspozycji i zapobiegania reakcji* (ERP) do bulimii. Zasada: **wytrzymanie** bez wymiotów przez 45–90 minut *uczy mózg*, że można **tolerować** lęk bez kompensacji. Każde takie przerwanie *osłabia* cykl. Po 3–5 udanych przerwaniach lęk po epizodzie znacząco spada — mózg nauczył się, że epizod **nie** prowadzi do katastrofy. Fairburn (2008): ta interwencja wprowadzana jest w **etapie 2 CBT-E** (sesje 5–8), po ustabilizowaniu regularnego jedzenia. ERP dla bulimii daje dalszą redukcję epizodów o 30–50%.

01 ● Logika przerwania cyklu

Bez przerwania: Epizod → lęk, wstyd → kompensacja → chwilowa ulga → *mózg uczy się: epizod wymaga wymiotów* → kolejny epizod.

Z przerwaniami: Epizod → lęk, wstyd → **tolerancja** 45–90 min bez kompensacji → lęk samoistnie opada → *mózg uczy się: epizod NIE wymaga wymiotów* → cykl osłabiony.

Mechanizm habituacji: lęk po epizodzie ma charakterystyczną krzywą — narasta, osiąga szczyt, potem *samoistnie* opada w ciągu 45–90 minut. Każde przerwanie uczy mózg, że **można** przetrwać lęk bez wymiotów.

02 = Sześć kroków po epizodzie

1 · NIE KOMPENSUJ

Bez wymiotów, środków, diuretyków, ćwiczeń kompensacyjnych, głodówki „na pokutę”. Decyzja świadoma.

2 · ZMIEN KONTEKST

Wyjdź z kuchni, łazienki, miejsca epizodu. Idź gdzie indziej. Fizyczna zmiana otoczenia redukuje impuls.

3 · TOLERANCJA 45–90 MIN

Wytrzymaj lęk. Krzywa lęku *samoistnie* opada w ciągu godziny. Stoper pomaga.

4 · KONTAKT Z OSOBĄ WSPARCIA

SMS, telefon, krótka rozmowa. Nie musisz mówić co się stało — wystarczy obecność.

5 · AKCEPTACJA

„Jedzenie się wchłonie. Świat się nie zawali. Mózg się nauczy.”. Wymioty cofają tylko 30–50% kalorii (Kaye 1993).

6 · NASTĘPNY POSIŁEK WG PLANU

Najbliższa okazja jedzenia z planu 3+2 — **nie pomijaj**. Wróć do schematu.

03 Mój plan awaryjny — trzy sytuacje

Plan awaryjny przygotowuje się **na zimno**, nie w momencie kryzysu. Spisz konkrety — kogo zadzwonisz, dokąd pójdziesz, co powiesz sobie.

SYTUACJA A — SAM/-A W DOMU WIECZOREM

— gdzie pójdę, kogo zadzwonię, co zrobię

SYTUACJA B — W PRACY LUB SZKOLE

— jak się ukryć przed impulsem, co zrobić w przerwie

SYTUACJA C — W TOWARZYSTWIE, RESTAURACJI

— jak unikać łązienki, kogo poprosić o wsparcie

04 Rejestr przerw — uczenie się

Każde udane przerwanie cyklu to **sukces** — odnotuj je. Każda nieudana próba to *dana*, którą warto omówić na sesji. Bez ocen, bez kary.

DATA	CZY PRZERWAŁEM/-AM?	LĘK SZCZYT (0-10)	CO POMOGŁO · CO UTRUDNIŁO

Klucz: przerwanie cyklu jest *najtrudniejszą*, ale *najsilniejszą* behawioralną interwencją w bulimii. W momencie po epizodzie impuls do kompensacji jest **natychmiastowy i ogromny** — to nie kwestia silnej woli, to fizjologia (lęk + uczenie się). Rosen & Leitenberg (1982) udowodnili: *habitucja* przez tolerancję dyskomfortu redukuje epizody o 30-50% u pacjentów, którzy stosują ją systematycznie. Każde udane przerwanie to nie tylko „*tym razem się udało*” — to **uczenie się**, które zmienia mózg. Po 3-5 przerwaniach lęk po epizodzie znacząco spada, bo mózg „wie”, że minie. To dosłownie *neuroplastyczność* — przerywanie cyklu rzeźbi nowe ścieżki neuronalne. Pierwsze próby są najtrudniejsze — wymagają planu awaryjnego (sekcja 3), wsparcia bliskiej osoby, czasem kontaktu z terapeutą między sesjami. Każda nieudana próba *nie* jest porażką — jest *daną*, którą warto omówić na sesji. Co utrudniło? Czego brakowało? To paliwo dla następnej próby. Etap 2 CBT-E (sesje 5-8) jest często **punktem zwrotnym** terapii.